

KlinikIQ General Surgery Cases Ultra Refined Report

Kapsam: Klinik Branş Seç / Klinik Vakalar / Olgular / Diğer Olgular içindeki branchId=general-surgery olan 27 standart vaka işlendi. TUS Spot Olgular, Hap Bilgi, glossary, API endpointleri, environment değişkenleri ve component mimarisi değiştirilmedi.

Editoryal odak: akut karın, hepatobiliyer cerrahi, travma, vasküler aciller, fitik, kolorektal/proktoloji, endokrin cerrahisi, meme cerrahisi, üst GIS ve cerrahi enfeksiyonlarda klinik karar algoritması, tetkik-olgu katmanı ve seçenek/feedback kalitesi güçlendirildi.

Metrik	Değer
Taranan Genel Cerrahi vakası	27
Güncellenen vaka	27
Option feedback yeniden yazımı	135
Kısa yorum yeniden yazımı	65
Alakasız tetkik kaldırma/gizleme	67
Scientific concern	0

Vaka Bazlı Coverage Özeti

v163-new-006-sag-alt-kadran-agrisi - Sağ alt kadran ağrısı

Alt alan: Akut karın / genel cerrahi

Öğrenme hedefi: Periumbilikal ağrının sağ alt kadrana göçü, lokal periton irritasyonu ve komprese olmayan genişlemiş apendiks bulgusunu birleştirerek akut apandisit tanısına ulaşma.

Yeni soru: Göç eden sağ alt kadran ağrısı, lokal periton irritasyonu, inflamasyon yüksekliği ve USG'de komprese olmayan genişlemiş apendiks saptanan bu hastada en olası tanı hangisidir?

Doğru cevap: Akut apandisit

Güçlendirilen tetkik/veri: Hemogram ve inflamasyon paneli, Tam idrar analizi, Sağ alt kadran ultrasonografisi

Kaldırılan/yeniden sınıflanan eski tetkikler: Tam kan sayımı, Abdominal ultrasonografi

- Ağrının periumbilikal bölgeden sağ alt kadrana göç etmesi apandisit tipik visseral-somatik ağrı geçişini düşündürür.
- McBurney hassasiyeti, lokal rebound ve defans sağ alt kadranda lokal periton irritasyonunu gösterir.
- USG'de komprese olmayan 8 mm apendiks görülmesi inflamasyonun anatomik kanıtıdır.

v167-new-047-ates-ve-sag-ust-kadran-agrisi - Ateş ve sağ üst kadran ağrısı

Alt alan: Hepatobiliyer / biliyer kaynak kontrolü

Öğrenme hedefi: Akut kolanjitte antibiyotik ve resüsitasyonun yanında enfekte-obstrükte safra yolunun ERCP ile drene edilmesi gerektiğini ayırt etme.

Yeni soru: Antibiyotik ve sıvı resüsitasyonu başlanan, ateş-titrete, sağ üst kadran ağrısı, ikter, kolestatik laboratuvar paterni ve USG'de distal koledok taşı bulunan bu hastada en uygun kaynak kontrol yaklaşımı hangisidir?

Doğru cevap: Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi ile safra yolu drenajı

Güçlendirilen tetkik/veri: Hemogram ve inflamasyon paneli, Karaciğer ve safra yolu paneli, Böbrek fonksiyonu ve laktat, Koagülasyon paneli, Abdominal ultrasonografi, Kan kültürü

Kaldırılan/yeniden sınıflanan eski tetkikler: Alkalen fosfataz, Gebelik testi / serum beta-hCG, Total bilirubin, Tam idrar analizi

- Ateş-titrete, sağ üst kadran ağrısı ve skleral ikter birlikteliği Charcot triadı ile akut kolanjiti düşündürür.
- Direkt bilirubin, ALP ve GGT yüksekliği biliyer obstrüksiyonla uyumlu kolestatik laboratuvar paternini gösterir.
- Ultrasonografide dilate koledok ve distal koledok taşı görülmesi, enfekte safra yolunda drenaj gerektiren mekanik tıkanıklığı ortaya koyar.

v168-new-059-ates-ve-sarilikla-basvuran-hasta - Ateş ve sarılıkla başvuran hasta

Alt alan: Akut karın / genel cerrahi

Öğrenme hedefi: Reynolds pentadı özellikleri gelişen kolanjitte antibiyotik/resüsitasyonla eş zamanlı ERCP ile kaynak kontrolü gerektiğini ayırt etme.

Yeni soru: İntravenöz sıvı ve geniş spektrumlu antibiyotik başlanmış, hipotansiyon ve konfüzyon eşlik eden akut kolanjit tablosundaki bu hastada en uygun kaynak kontrol yaklaşımı hangisidir?

Doğru cevap: Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi ile biliyer drenaj

Güçlendirilen tetkik/veri: Hemogram, inflamasyon ve sepsis paneli, Karaciğer ve safra yolu paneli, Organ etkilenimi ve girişim öncesi değerlendirme, Abdominal ultrasonografi

Kaldırılan/yeniden sınıflanan eski tetkikler: Alkalen fosfataz, Gebelik testi / serum beta-hCG, Total bilirubin, Tam idrar analizi

- Ateş, sağ üst kadranda ağrısı ve sarılık akut kolanjitin temel klinik örüntüsünü oluşturur.
- Hipotansiyon ve konfüzyon ağır kolanjit ve sepsis riski açısından acil drenaj gerektiren sistemik etkilenimi gösterir.
- USG’de koledok dilatasyonu ve distal taş görülmesi enfekte obstrüksiyonun biliyer drenajla kontrol edilmesi gerektiğini gösterir.

v172-new-074-siddetli-karın-agrısı-ve-atriyal-fibrilasyon - Şiddetli karın ağrısı ve atriyal fibrilasyon

Alt alan: Vasküler acil / genel cerrahi ilişkili

Öğrenme hedefi: Atriyal fibrilasyon, ani şiddetli karın ağrısı, metabolik asidoz ve laktat yüksekliğinde kontrastlı BT anjiyografinin tanınal önceliğini ayırt etme.

Yeni soru: Atriyal fibrilasyonu olan, muayene bulgusuna göre orantısız şiddetli karın ağrısı, metabolik asidoz ve laktat yüksekliği saptanan bu hastada en uygun tanınal test hangisidir?

Doğru cevap: Kontrastlı BT anjiyografi

Güçlendirilen tetkik/veri: Kan gazı ve laktat, Hemogram ve böbrek fonksiyonu

Kaldırılan/yeniden sınıflanan eski tetkikler: Beyaz küre sayısı, Serum laktat, Tam idrar analizi, Abdominal ultrasonografi

- Atriyal fibrilasyon ve düzensiz antikoagülan kullanımı embolik mezenter arter tıkanıklığı riskini artırır.
- Ani başlayan, muayene bulgusuna göre orantısız şiddetli karın ağrısı akut mezenter iskemi için tipiktir.
- Laktat yüksekliği ve metabolik asidoz bağırsak hipoperfüzyonu olasılığını destekler ve vasküler görüntüleme gerektirir.

v173-new-086-yasli-hastada-mekanik-obstrüksiyon - Yaşlı hastada mekanik obstrüksiyon

Alt alan: Akut karın / genel cerrahi

Öğrenme hedefi: Kolesistoenterik fistül sonrası ektopik safra taşının mekanik barsak obstrüksiyonu yapabileceğini klinik ve BT bulgularıyla ilişkilendirme.

Yeni soru: Yaşlı, safra taşı öyküsü olan ve mekanik ileus bulguları gelişen bu hastada BT’de pnömobilia ve terminal ileumda ektopik taş saptanmasına göre en olası tanı hangisidir?

Doğru cevap: Safra taşı ileusu

Güçlendirilen tetkik/veri: Elektrolitler ve böbrek fonksiyonu, Hemogram ve laktat, Kontrastlı abdominal BT

Kaldırılan/yeniden sınıflanan eski tetkikler: Temel biyokimya ve elektrolitler, Tam idrar analizi, Abdominal bilgisayarlı tomografi

- Yaşlı hastada safra taşı öyküsü ve mekanik obstrüksiyon bulguları birlikte bulunur.
- BT’de dilate ince barsak ansları mekanik ileusu gösterir.
- Pnömobilia ve ektopik safra taşı görülmesi kolesistoenterik fistül üzerinden gelişen safra taşı ileusunu destekler.

v174-new-093-travma-sonrası-karın-hassasiyeti - Travma sonrası karın hassasiyeti

Alt alan: Travma cerrahisi

Öğrenme hedefi: Travma algoritmasında instabil hasta + pozitif FAST kombinasyonunda BT beklemeden cerrahi kanama kontrolüne geçilmesi gerektiğini ayırt etme.

Yeni soru: Künt karın travması sonrası hemodinamik instabil olan ve FAST incelemesinde intraperitoneal serbest sıvı saptanan bu hastada en uygun yaklaşım hangisidir?

Doğru cevap: Acil eksploratif laparotomi yapılması

Güçlendirilen tetkik/veri: Hemogram, laktat ve transfüzyon hazırlığı, FAST ultrasonografi

Kaldırılan/yeniden sınıflanan eski tetkikler: Kapiller kan glukozu, Tam idrar analizi

- Künt karın travması sonrası hipotansiyon ve taşikardi hemorajik şok düşündürür.

- FAST incelemede birden fazla alanda serbest sıvı görülmesi intraperitoneal kanama lehinedir.
- İnstabil travma hastasında BT beklemek cerrahi kanama kontrolünü geciktirir.

v174-new-094-sag-ust-kadran-agrisi - Sağ üst kadran ağrısı

Alt alan: Hepatobiliyer / biliyer kaynak kontrolü

Öğrenme hedefi: Murphy bulgusu, lökositoz ve USG'de taş-duvar kalınlaşması-perikolesistik sıvı birlikteliğini akut kolesistit tanısıyla ilişkilendirme.

Yeni soru: Yağlı öğün sonrası uzayan sağ üst kadran ağrısı, ateş, pozitif Murphy bulgusu ve USG'de taş-duvar kalınlaşması-perikolesistik sıvı saptanan bu hastada en olası tanı hangisidir?

Doğru cevap: Akut kolesistit

Güçlendirilen tetkik/veri: Hemogram ve inflamasyon paneli, Karaciğer/safra yolu ve pankreas paneli, Sağ üst kadran ultrasonografisi

Kaldırılan/yeniden sınıflanan eski tetkikler: Beyaz küre sayısı, Gebelik testi / serum beta-hCG, Tam idrar analizi, Abdominal ultrasonografi

- Yağlı öğün sonrası başlayan ve saatlerce süren sağ üst kadran ağrısı safra kesesi kaynaklı inflamasyonu düşündürür.
- Pozitif Murphy bulgusu safra kesesi inflamasyonuna lokalize muayene bulgusudur.
- USG'de taş, duvar kalınlaşması ve perikolesistik sıvı akut kolesistitin anatomik kanıtını oluşturur.

v175-new-107-yumusak-doku-enfeksiyonunda-hizla-kotulesme - Yumuşak doku enfeksiyonunda hızla kötüleşme

Alt alan: Cerrahi enfeksiyonlar

Öğrenme hedefi: Nekrotizan fasiitte antibiyotik gerekli olsa da cerrahi eksplorasyon ve geniş debridmanın kaynak kontrolü olduğunu ayırt etme.

Yeni soru: Diyabetik hastada küçük kesi sonrası hızla ilerleyen, orantısız ağrı, toksisite, krepitasyon, laktat yüksekliği ve yumuşak dokuda gaz ile seyreden bu tabloda en uygun acil yaklaşım hangisidir?

Doğru cevap: Acil cerrahi eksplorasyon ve geniş debridman

Güçlendirilen tetkik/veri: Hemogram, metabolik panel ve laktat, Yumuşak doku grafisi

Kaldırılan/yeniden sınıflanan eski tetkikler: Beyaz küre sayısı, Serum laktat

- Diyabet zemininde küçük kesi sonrası enfeksiyonun saatler içinde hızla ilerlemesi nekrotizan enfeksiyon riskini artırır.
- Ağrının cilt bulgularına göre orantısız olması nekrotizan fasiit için kritik klinik ipucudur.
- Krepitasyon, yumuşak dokuda gaz ve laktat yüksekliği acil cerrahi debridman gerektiren ağır doku enfeksiyonunu destekler.

v176-new-120-diskilama-sonrasi-anal-agri - Dışkılama sonrası anal ağrı

Alt alan: Kolorektal / proktoloji

Öğrenme hedefi: Posterior orta hat lineer yırtık, dışkılama sırasında keskin ağrı ve sınırlı parlak kanamayı akut anal fissür tanısıyla ilişkilendirme.

Yeni soru: Kabızlık sonrası dışkılama sırasında cam kesiği tarzında ağrı, kısa süreli parlak kırmızı kanama ve posterior orta hatta lineer yırtık izlenen bu hastada en olası tanı hangisidir?

Doğru cevap: Akut anal fissür

Kaldırılan/yeniden sınıflanan eski tetkikler: Hemogram ve temel inflamasyon paneli

- Sert dışkılama sonrası başlayan cam kesiği tarzı ağrı akut anal fissür için tipiktir.
- Kanamanın az miktarda ve parlak kırmızı olması distal anorektal kaynakla uyumludur.
- Posterior orta hatta yüzeyel lineer yırtık görülmesi tanıyı doğrudan destekler.

v177-new-127-ani-bacak-agrisi-ve-soğukluk - Ani bacak ağrısı ve soğukluk

Alt alan: Vasküler acil / genel cerrahi ilişkili

Öğrenme hedefi: Atriyal fibrilasyon zemininde ani ağrı, solukluk, soğukluk, nabız kaybı ve nörolojik defisit tehdit altındaki ekstremitayı gösterdiğini ayırt etme.

Yeni soru: Atriyal fibrilasyon öyküsü olan, ani bacak ağrısı, soğukluk, nabız kaybı, duyu ve motor kayıp gelişen bu hastada en uygun acil yaklaşım hangisidir?

Doğru cevap: Acil sistemik heparinizasyon ve revaskülarizasyon için damar cerrahisi girişimi

Güçlendirilen tetkik/veri: Yatak başı arteriyel Doppler, Koagülasyon, böbrek fonksiyonu ve kas hasarı paneli

Kaldırılan/yeniden sınıflanan eski tetkikler: Hemogram ve temel inflamasyon paneli, El Doppler değerlendirmesi

- Atriyal fibrilasyon ve düzensiz antikoagülasyon embolik arter tıkanıklığı riskini artırır.
- Ani ağrı, solukluk, soğukluk ve distal nabız kaybı akut ekstremitte iskemisinin temel bulgularıdır.
- Duyu ve motor kayıp ekstremitenin tehdit altında olduğunu ve acil revaskülarizasyon gerektiğini gösterir.

v178-new-137-epigastrik-agri-ve-kusma - Epigastrik ağrı ve kusma

Alt alan: Pankreatobiliyer

Öğrenme hedefi: Lipaz yüksekliği, sırta yayılan epigastrik ağrı ve hemokonsantrasyon/BUN artışında erken intravenöz sıvı, analjezi ve yakın izlem gerekliliğini ayırt etme.

Yeni soru: Sırta yayılan epigastrik ağrı, lipaz yüksekliği, hemokonsantrasyon ve BUN artışı olan bu hastada başlangıçta en uygun tedavi yaklaşımı hangisidir?

Doğru cevap: Agresif intravenöz sıvı replasmanı, analjezi ve yakın klinik izlem

Güçlendirilen tetkik/veri: Pankreas enzimleri, Hemokonsantrasyon ve böbrek perfüzyonu, Abdominal ultrasonografi

Kaldırılan/yeniden sınıflanan eski tetkikler: Hematokrit, Kan üre azotu, Serum lipaz, Tam idrar analizi

- Sırta yayılan epigastrik ağrı ve öne eğilmekle rahatlama akut pankreatit için tipiktir.
- Serum lipazın belirgin yüksek olması tanıyı destekler.
- BUN yüksekliği ve hemokonsantrasyon hipovolemi riskini gösterdiği için erken sıvı tedavisini öncelikli yapar.

v183-new-190-kasik-sisligi-ve-kusma - Kasık şişliği ve kusma

Alt alan: Fıtık ve karın duvarı

Öğrenme hedefi: Redükte edilemeyen ağrılı kasık kitlesi, kusma, gaz-gaita çıkaramama ve distansiyonda zorlayıcı redüksiyon yerine acil cerrahi değerlendirme gerekliliğini ayırt etme.

Yeni soru: Redükte edilemeyen ağrılı kasık kitlesi, kusma, gaz çıkaramama, distansiyon ve obstrüksiyon bulguları olan bu hastada en uygun acil yaklaşım hangisidir?

Doğru cevap: Acil cerrahi değerlendirme ve operatif onarım

Güçlendirilen tetkik/veri: Hemogram ve perfüzyon paneli, Ayakta direkt karın grafisi

Kaldırılan/yeniden sınıflanan eski tetkikler: Hemogram ve temel inflamasyon paneli, Tam idrar analizi

- Ağrılı kasık kitlesinin artık redükte edilememesi inkarsere fıtığı gösterir.
- Kusma, gaz çıkaramama ve distansiyon mekanik obstrüksiyon geliştiğini destekler.
- Cilt eritemi, laktat yüksekliği ve taşikardi strangülasyon riskini düşündürür.

v184-new-194-sag-ust-kadran-agrisi - Sağ üst kadran ağrısı

Alt alan: Hepatobiliyer / biliyer kaynak kontrolü

Öğrenme hedefi: Safra kesesi taşına eşlik eden duvar kalınlaşması ve perikolesistik sıvının akut kolesistiti biliyer kolikten ayırdığını kavrama.

Yeni soru: Yağlı yemek sonrası uzamış sağ üst kadran ağrısı, ateş, pozitif Murphy bulgusu ve USG'de safra kesesi taşı-duvar kalınlaşması-perikolesistik sıvı saptanan hastada en olası tanı hangisidir?

Doğru cevap: Akut kolesistit

Güçlendirilen tetkik/veri: Hemogram ve CRP, Bilirubin, karaciğer enzimleri ve lipaz, Sağ üst kadran ultrasonografisi

Kaldırılan/yeniden sınıflanan eski tetkikler: Beyaz küre sayısı, Gebelik testi / serum beta-hCG, Abdominal ultrasonografi

- Sağ üst kadran ağrısının uzaması ve sağ omuza yayılması safra kesesi kaynaklı inflamasyonu düşündürür.
- Pozitif Murphy bulgusu safra kesesi inflamasyonu için lokalize muayene bulgusudur.
- USG'de taş, duvar kalınlaşması ve perikolesistik sıvı akut kolesistiti destekler.

v185-new-222-ani-sirt-agrisi-ve-hipotansiyon - Ani sırt ağrısı ve hipotansiyon

Alt alan: Vasküler acil / genel cerrahi ilişkili

Öğrenme hedefi: Hemodinamik instabil AAA şüphesinde tanısal gecikme yerine resüsitasyonla eş zamanlı acil vasküler onarım gerekliliğini ayırt etme.

Yeni soru: Ani sırt-karın ağrısı, hipotansiyon, pulsatil abdominal kitle ve yatak başı USG'de geniş abdominal aort anevrizması saptanan bu hastada en uygun acil yaklaşım hangisidir?

Doğru cevap: Hemodinamik resüsitasyonla eş zamanlı acil damar cerrahisi onarımı

Güçlendirilen tetkik/veri: Hemogram, koagülasyon ve kan ürünü hazırlığı, Yatak başı abdominal ultrasonografi

Kaldırılan/yeniden sınıflanan eski tetkikler: İleri doğrulama öncesi temel laboratuvar, Tam idrar analizi

- Hipertansiyon ve sigara öyküsü AAA riskini artırır.
- Ani sırta yayılan karın ağrısı, hipotansiyon ve soluk-terli görünüm rüptür/hemorajik şoku düşündürür.
- Yatak başı USG'de 7.2 cm AAA görülmesi acil vasküler onarım gerektiren anatomik kaynağı gösterir.

v185-new-223-ates-sarilik-ve-sag-ust-kadran-agrisi - Ateş, sarılık ve sağ üst kadran ağrısı

Alt alan: Hepatobiliyer / biliyer kaynak kontrolü

Öğrenme hedefi: Antibiyotik ve sıvıya ek olarak biliyer obstrüksiyonun ERCP ile drene edilmesi gerektiğini yakın çeldiricilerden ayırt etme.

Yeni soru: Antibiyotik ve sıvı resüsitasyonu başlanan, ağır akut kolanjit bulguları ve USG'de koledok taşı olan bu hastada eklenmesi gereken en uygun tedavi hangisidir?

Doğru cevap: Acil ERCP ile biliyer drenaj

Güçlendirilen tetkik/veri: Sepsis ve kolestatik paneli, Abdominal ultrasonografi

Kaldırılan/yeniden sınıflanan eski tetkikler: Alkalen fosfataz, Gebelik testi / serum beta-hCG, Total bilirubin, Tam idrar analizi

- Ateş, sarılık ve sağ üst kadran ağrısı Charcot triadı ile akut kolanjiti düşündürür.
- Hipotansiyon ve konfüzyona eğilim ağır enfeksiyon ve organ perfüzyon riski oluşturur.
- USG'de koledok taşı ve dilatasyon kaynak kontrolü gerektiren mekanik biliyer obstrüksiyonu gösterir.

v185-new-224-ani-epigastrik-agri-ve-tahta-karin - Ani epigastrik ağrı ve tahta karın

Alt alan: Akut karın / genel cerrahi

Öğrenme hedefi: Tahta karın ve diyafram altında serbest hava varlığında endoskopi/antiasit beklemek yerine resüsitasyon, antibiyotik ve acil perforasyon onarımı gerektiğini ayırt etme.

Yeni soru: NSAİİ kullanımı olan, ani epigastrik ağrı sonrası yaygın peritonit gelişen ve grafide diyafram altında serbest hava saptanan bu hastada en uygun yaklaşım hangisidir?

Doğru cevap: Acil cerrahi değerlendirme, resüsitasyon ve perforasyon onarımı

Güçlendirilen tetkik/veri: Hemogram, laktat ve böbrek fonksiyonu, Ayakta akciğer grafisi

Kaldırılan/yeniden sınıflanan eski tetkikler: Hemogram ve temel inflamasyon paneli, Tam idrar analizi

- NSAİİ kullanımı ve dispepsi öyküsü peptik ülser zeminini destekler.
- Ani başlayan ağrı ve tahta karın yaygın peritoniti gösterir.
- Diyafram altında serbest hava içi boş organ perforasyonu için cerrahi kaynak kontrolü gerektiren bulgudur.

v186-new-239-diskilama-sirasinda-siddetli-agri - Dışkılama sırasında şiddetli ağrı

Alt alan: Kolorektal / proktoloji

Öğrenme hedefi: Anal fissürü iç hemoroid, perianal fistül ve rektum kanserinden ayıran ağrı-zamanlama ve inspeksiyon bulgularını kullanma.

Yeni soru: Sert dışkılama sonrası cam kesiği tarzında ağrı, dışkılama sonrası süren ağrı ve posterior orta hatta lineer yırtık izlenen bu hastada en olası tanı hangisidir?

Doğru cevap: Anal fissür

Kaldırılan/yeniden sınıflanan eski tetkikler: Gebelik testi / serum beta-hCG, Hemogram ve temel inflamasyon paneli

- Ağrının dışkılama sırasında cam kesiği tarzında olması anal fissür için tipiktir.
- Kabızlık sonrası az miktarda parlak kırmızı kanama distal anorektal yırtıkla uyumludur.
- Posterior orta hatta lineer yırtık görülmesi tanıyı doğrudan destekler.

v187-new-253-siddetli-karin-agrisi-ve-hafif-muayene-bulgusu - Şiddetli karın ağrısı ve hafif muayene bulgusu

Alt alan: Vasküler acil / genel cerrahi ilişkili

Öğrenme hedefi: Atriyal fibrilasyon, ani şiddetli ağrı, başlangıçta hafif muayene ve laktat yüksekliğini akut mezenter iskemi tanısıyla ilişkilendirme.

Yeni soru: Atriyal fibrilasyonu olan, muayene bulgusuna göre orantısız şiddetli karın ağrısı, laktat yüksekliği ve BT anjiyografide SMA dolum defekti bulunan hastada en olası tanı hangisidir?

Doğru cevap: Akut mezenter iskemi

Güçlendirilen tetkik/veri: Kan gazı ve laktat, Kontrastlı BT anjiyografi

Kaldırılan/yeniden sınıflanan eski tetkikler: Serum laktat, Tam idrar analizi, Abdominal ultrasonografi

- Atriyal fibrilasyon ve düzensiz antikoagülasyon embolik mezenter arter tıkanıklığı riskini artırır.
- Karın ağrısının muayene bulgularına göre orantısız şiddette olması akut mezenter iskemi için tipiktir.
- Laktat yüksekliği ve BT anjiyografide SMA dolum defekti bağırsak iskemisini destekler.

v188-new-268-epigastrik-agri-ve-lipaz-yuksekligi - Epigastrik ağrı ve lipaz yüksekliği

Alt alan: Pankreatobiliyer

Öğrenme hedefi: Akut pankreatitte lipaz yüksekliği, tipik ağrı ve komplikasyon olmaması durumunda sıvı-analjezi-beslenme/izlem yaklaşımını seçme.

Yeni soru: Tipik epigastrik-sırtta yayılan ağrı ve belirgin lipaz yüksekliği olan, kolanjit veya enfekte nekroz bulgusu bulunmayan bu hastada en uygun başlangıç tedavisi hangisidir?

Doğru cevap: İntravenöz sıvı, analjezi, oral alımın düzenlenmesi ve yakın klinik izlem

Güçlendirilen tetkik/veri: Pankreas enzimleri, Biyokimya ve şiddet izlemi, Abdominal ultrasonografi

Kaldırılan/yeniden sınıflanan eski tetkikler: Serum lipaz

- Epigastrik ağrının sırtta yayılması ve lipaz yüksekliği akut pankreatit tanısını destekler.
- USG'de koledok dilatasyonu ve sarılık olmaması acil ERCP gerektiren biliyer obstrüksiyonu desteklemez.
- Peritonit veya enfekte nekroz bulgusu olmadığı için başlangıç yaklaşımı destek tedavisidir.

v189-new-292-cilt-enfeksiyonunda-orantisiz-agri - Cilt enfeksiyonunda orantısız ağrı

Alt alan: Cerrahi enfeksiyonlar

Öğrenme hedefi: Orantısız ağrı, hızlı yayılım, krepitasyon, laktat ve yumuşak dokuda gaz bulgularını acil debridmanla ilişkilendirme.

Yeni soru: Diyabetik hastada hızlı ilerleyen, orantısız ağrı, toksisite, krepitasyon, laktat yüksekliği ve yumuşak dokuda gaz ile seyreden tabloda en uygun acil yaklaşım hangisidir?

Doğru cevap: Geniş spektrumlu antibiyotik ve acil cerrahi debridman

Güçlendirilen tetkik/veri: Sepsis ve doku hipoperfüzyon paneli, Yumuşak doku grafisi

Kaldırılan/yeniden sınıflanan eski tetkikler: Serum laktat

- Diyabet zemininde küçük kesi sonrası enfeksiyon hızla ilerlemiştir.
- Ağrının cilt bulgularına göre orantısız olması nekrotizan enfeksiyon için kritik ipucudur.
- Krepitasyon, yumuşak dokuda gaz ve laktat yüksekliği acil debridman gerektiren ağır tabloyu destekler.

v189-new-293-karin-sisligi-ve-gaz-cikaramama - Karın şişliği ve gaz çıkaramama

Alt alan: Kolorektal / proktoloji

Öğrenme hedefi: Kahve çekirdeği görünümü, distansiyon ve boş rektal ampulla bulgularında peritonit yoksa fleksibl sigmoidoskopi ile detorsiyonun ilk tedavi olduğunu kavrama.

Yeni soru: Peritonit bulgusu olmayan, distansiyon ve gaz-gaita çıkaramama ile gelen, grafide kahve çekirdeği görünümü saptanan bu hastada en uygun başlangıç tedavisi hangisidir?

Doğru cevap: Fleksibl sigmoidoskopi ile endoskopik detorsiyon

Güçlendirilen tetkik/veri: Hemogram, elektrolit ve laktat, Ayakta direkt karın grafisi

Kaldırılan/yeniden sınıflanan eski tetkikler: Hemogram ve temel inflamasyon paneli, Tam idrar analizi

- Karın distansiyonu, kabızlık ve gaz çıkaramama distal kolon obstrüksiyonunu düşündürür.
- Grafide kahve çekirdeği görünümü sigmoid volvulusu destekler.
- Peritonit ve laktat yüksekliği olmaması başlangıçta endoskopik detorsiyonu uygun kılar.

v189-new-294-supheli-tiroid-nodulu - Şüpheli tiroid nodülü

Alt alan: Endokrin cerrahisi

Öğrenme hedefi: Hipoekoik, düzensiz sınırlı, mikrokalsifikasyonlu solid nodülde ultrason eşliğinde İİAB gerektiğini; sintigrafinin düşük TSH durumunda öne çıktığını ayırt etme.

Yeni soru: Normal TSH değeri olan, 1.5 cm solid hipoekoik, düzensiz sınırlı ve mikrokalsifikasyon içeren tiroid nodülü bulunan bu hastada en uygun sonraki tanısıl yaklaşım hangisidir?

Doğru cevap: Ultrason eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi

Güçlendirilen tetkik/veri: Tiroid fonksiyon testi, Tiroid ultrasonografisi

Kaldırılan/yeniden sınıflanan eski tetkikler: Gebelik testi / serum beta-hCG, TSH

- Aile öyküsü ve çocuklukta radyasyon maruziyeti malignite riskini artırır.
- USG'de hipoekojenite, düzensiz sınır ve mikrokalsifikasyon yüksek şüphe bulgularıdır.
- TSH normal olduğundan düşük TSH'a yönelik sintigrafi yerine USG eşliğinde İİAB önceliklidir.

v194-new-327-yutma-sonrasi-agiza-gida-gelmesi - Yutma sonrası ağıza gıda gelmesi

Alt alan: Üst gastrointestinal cerrahi

Öğrenme hedefi: Sindirilmemiş gıda regürjitasyonu ve hipofarenks posteriorunda sakküler poş bulgusunu Zenker divertikülüyle ilişkilendirme.

Yeni soru: Yutma sonrası sindirilmemiş gıda regürjitasyonu, ağız kokusu, aspirasyon öyküsü ve baryumlu grafide hipofarenks posteriorunda sakküler poş izlenen hastada en olası tanı hangisidir?

Doğru cevap: Zenker divertikülü

Güçlendirilen tetkik/veri: Baryumlu özofagus grafisi, Akciğer grafisi

Kaldırılan/yeniden sınıflanan eski tetkikler: Hemogram ve temel inflamasyon paneli

- Sindirilmemiş gıdanın özellikle yatarken ağıza gelmesi divertikül içinde gıda birikimini düşündürür.
- Halitozis ve tekrarlayan öksürük aspirasyon riskini destekler.
- Baryumlu grafide hipofarenks posteriorunda sakküler poş görülmesi Zenker divertikülünün anatomik bulgusudur.

v194-new-328-agrisiz-sarilik-ve-kilo-kaybi - Ağrısız sarılık ve kilo kaybı

Alt alan: Akut karın / genel cerrahi

Öğrenme hedefi: Pankreas başı kitlesinin distal koledoku tıkayarak direkt hiperbilirubinemi, safra yolu dilatasyonu ve Courvoisier bulgusu oluşturabileceğini kavrama.

Yeni soru: Ağrısız obstrüktif sarılık, kilo kaybı, kolestatik laboratuvar paterni ve BT'de pankreas başında distal koledoku daraltan kitle saptanan bu hastada en olası tanı hangisidir?

Doğru cevap: Pankreas başı adenokarsinomu

Güçlendirilen tetkik/veri: Kolestaz ve karaciğer paneli, Abdominal ultrasonografi, Pankreas protokol kontrastlı BT, Tümör belirteci

Kaldırılan/yeniden sınıflanan eski tetkikler: Total bilirubin, Tam idrar analizi, Abdominal BT

- Ağrısız sarılık, koyu idrar, akolik dışkı ve kilo kaybı malign distal biliyer obstrüksiyon düşündürür.
- Direkt bilirubin, ALP ve GGT yüksekliği ekstrahepatik kolestaz paternini gösterir.
- BT'de pankreas başında distal koledoku daraltan kitle görülmesi obstrüksiyonun anatomik nedenini ortaya koyar.

v195-new-355-kusma-sonrasi-gogus-agrisi - Kusma sonrası göğüs ağrısı

Alt alan: Üst gastrointestinal cerrahi

Öğrenme hedefi: Özofagus perforasyonunda NPO, geniş spektrumlu antibiyotik, drenaj ve acil cerrahi/endoskopik onarım değerlendirmesinin gerektiğini ayırt etme.

Yeni soru: Güçlü kusma sonrası ani göğüs ağrısı, cilt altı krepitasyon ve BT'de distal özofagus komşuluğunda hava-sıvı kaçağı olan bu hastada en uygun acil yaklaşım hangisidir?

Doğru cevap: Ağızdan alımı kesmek, geniş spektrumlu antibiyotik başlamak ve acil cerrahi/endoskopik onarım değerlendirmek

Güçlendirilen tetkik/veri: Hemogram ve inflamasyon paneli, 12 derivasyon EKG, Kontrastlı toraks BT

Kaldırılan/yeniden sınıflanan eski tetkikler: Hemogram ve temel inflamasyon paneli, Toraks BT

- Ağrının güçlü kusma ataklarından sonra başlaması Boerhaave sendromu için tipik tetikleyicidir.

- Boyunda cilt altı krepatasyon özofagus perforasyonuna bağlı hava kaçağını düşündürür.
- BT’de distal özofagus komşuluğunda ekstraluminal hava, mediastinal sıvı ve plevral efüzyon perforasyonu destekler.

v195-new-356-kasik-altinda-agrili-sislik - Kasık altında ağrılı şişlik

Alt alan: Fıtık ve karın duvarı

Öğrenme hedefi: Pubik tüberkülün lateral-inferiorunda, inguinal ligament altında ağrılı redükte edilemeyen kitlenin inkarsere femoral herni düşündüğüünü kavrama.

Yeni soru: İnguinal ligament altında, pubik tüberkülün lateral-inferiorunda ağrılı redükte edilemeyen kitle ve USG’de femoral kanalda barsak ansı saptanan bu hastada en olası tanı hangisidir?

Doğru cevap: İnkarsere femoral herni

Güçlendirilen tetkik/veri: Hemogram ve laktat, Kasık ultrasonografisi

Kaldırılan/yeniden sınıflanan eski tetkikler: İleri doğrulama öncesi temel laboratuvar, Tam idrar analizi

- Kitle inguinal ligamentin altında ve pubik tüberkülün lateral-inferiorunda yerleşmiştir.
- Şişliğin hassas ve redükte edilemez olması inkarsere fıtık lehinedir.
- USG’de femoral kanal düzeyinde barsak ansı içeren herni kesesi görülmesi femoral herni tanısını destekler.

v195-new-357-erken-evre-meme-kitlesi - Erken evre meme kitlesi

Alt alan: Meme cerrahisi

Öğrenme hedefi: Küçük invaziv meme kanseri ve klinik/USG nod negatif aksillada rutin aksiller diseksiyon yerine sentinel lenf nodu biyopsisi gerektiğini ayırt etme.

Yeni soru: Kor biyopsiyle invaziv meme kanseri doğrulanmış, küçük primer tümörü olan ve klinik/ultrasonografik olarak aksillası nod negatif görünen bu hastada aksiller evreleme için en uygun yaklaşım hangisidir?

Doğru cevap: Sentinel lenf nodu biyopsisi

Güçlendirilen tetkik/veri: Meme görüntüleme, Kor biyopsi

Kaldırılan/yeniden sınıflanan eski tetkikler: Gebelik testi / serum beta-hCG, İleri doğrulama öncesi temel laboratuvar, Aksiller ultrasonografi

- Kor biyopsi invaziv duktal karsinomu doğrulamıştır.
- Tümör küçük ve erken evre bağlamındadır.
- Aksillada klinik ve ultrasonografik patolojik lenf nodu izlenmemesi sentinel lenf nodu biyopsisini uygun kılar.